なぜACPはうまくいかないのか — 3ステージ・4つの質問・予後の伝え方

中川俊一（コロンビア大学 成人緩和ケア部門）の m3.com 臨床ニュース連載（全10回・2024年12月〜2025年2月）を、ICUの家族面談とACPで使える形に整理した要約。原典は書籍『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社、2024）。原文の引き写しではなく、連載の論点を横断してまとめ直したもの。

緩和ケア　ACP　Goals of Care　意思決定支援　家族面談

§0 要点 — 3行まとめと、この連載の肝

重い会話がこじれる原因の多くは、話す順番と聞き方にあります。先に全体像を3行で、続けて面談でいちばん効く「肝」を示します。

3行まとめ

1. **重い会話は「病状 → ゴール → 治療の選択肢」の順に進める。最も多い失敗は、ゴールを飛ばしていきなり心肺蘇生の希望を聞くこと**
2. **ACPは事前指示書を作るイベントではない。本人の価値観をできるだけ多くの家族と共有し続けるプロセスで、書類のことは忘れてよい**
3. **ゴールが決まったら、医療者は推奨つきで提案する。中立に「どうしますか」と聞くのは、尊重に見えて決断の丸投げになる**

肝

相手に選ばせず、医師から提案する。ただし状況によって提案の強さを変える。

提案と誘導を分けるのは、土台に本人の価値観があるかどうか。強さを決める要素は3つです。

① 医学的な確かさ	② 価値観の明確さ	③ 委ねたい気持ち
無益なことがどこまで明らかか	本人が何を大切にするかが聴けているか	家族が決定を医療者に委ねたいか

「しません」と言い切る informed assent と、方針を示して反対があれば言ってもらう informed nondissent は、どちらも同じ線の強い側にあります（§3）。 [Curtis JAMA2020] [AHA 2025]

§1 連載10回の構成

10回は「順番（3ステージ）」「ACPの考え方」「難しい場面の言い方」「スキルの磨き方」の4つの塊に分かれます。

表1｜連載の構成

回	テーマ	一言で
01	はじめに	緩和ケア医はコミュニケーションの専門家。日本の医師は体系的に教わっていない
02	2nd：治療ゴールの設定	治療の話にいきなり入らない。SDMは段階で主従が入れ替わる
03	3rd：治療オプションの相談	中立の はい／いいえ の質問は、どちらにも良さがあると示唆してしまう
04	理想的なACPの形	事前指示書が効くには7条件がすべて要る。価値観の共有に集中する
05	ACPで尋ねる4つの質問	楽しみ → 生きがい → 気がかり → 許容できない状態の順に、上限と下限を探る
06	「私は死ぬんですか？」	予後ははぐらかさない。時間の単位で、許可を得て、沈黙を置いて伝える
07	「本人には言わないで」	家族の不安に対応したうえで、どこまで知りたいかを本人に聞く
08	「時間がない」への答え	ゴールの段を飛ばすと、かえって遠回りになる（ERで5分の実例）
09	反復という名のオウム返し	語尾を繰り返すだけの反復は思考停止。理由を聞いて掘る
10	コミュニケーションはスキル	手術手技と同じ。面談ごとに学びを1つ書き留める

§2 3ステージ — 順番を守ることがすべて

病状、ゴール、治療の選択肢の順に話し、段ごとに主導する側が入れ替わります。いちばん多い失敗は、2つ目のゴールの段を飛ばすことです。

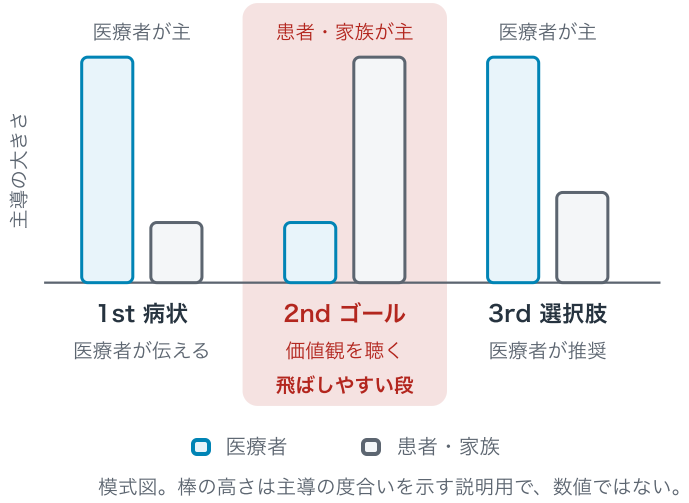


図1. 3ステージで主従が入れ替わる。病状と治療の選択肢は医療者が主導し、間にあるゴールの段だけは患者・家族が主になる。

> 真ん中の段で主役が入れ替わるのが要点です。ここを飛ばすと、治療の判断材料が医学情報だけになり、**「生きるか死ぬか」**の二択になります。

表2｜3ステージの中身

ステージ	やること	主導
1st 病状の説明	2分程度のサマリーで現状と見通しを伝える。予後がはっきりしていれば曖昧にしない	医療者
2nd 治療ゴールの設定	本人が何を大切にし、何を恐れ、どう生きたいかを聴く	**患者・家族が主**、医療者は従
3rd 治療オプションの相談	聴いたゴールを医療行為に「翻訳」して推奨する	**医療者が主**、患者・家族は従

よくある失敗と、ゴールが要る理由

- **2ndの省略**：心停止時の心臓マッサージの希望をいきなり尋ねる、透析の可否を家族の話し合いに預ける。1stはこなせても、2ndを飛ばしてしまう。
- **はい／いいえで始めると泥沼になる**：心肺蘇生に「いいえ」と答えても、抗菌薬・昇圧薬・人工栄養・透析・採血・画像と質問が延々と続き、患者側には答えようがない。

- **「どう生きるか」で決める**：救命できても、長期人工呼吸のあと1年後に自立して暮らせるのは12%未満という報告がある [Nelson AJRCCM2010]。元の機能に戻れないなら治療を望まない人が多い [Fried NEJM2002]。

SDMをパソコン選びで考える

表3｜3人の店員と、医療の意思決定の型

店員の対応	型	医療に置き換えると
「これが間違いありません」と1台を勧める	パターナリズム	価値観を聴かずに決める
性能の数字を並べて「どちらにしますか」	情報を浴びせて委ねる	ICUで心臓マッサージの希望を尋ねるのと同じ。素人には判断材料にならない
使い道と予算を聞き、それに合う1台を勧める	ゴールを聞いてから推奨	前半が2nd、後半が3rd

SDMは、双方が同じ情報を同じ重みで扱うことではなく、段階ごとに主導する側が入れ替わる [Elwyn BMJ2010]。

§3 提案と誘導の境目、提案の強さ — 3rdステージ

中立の「どうしますか」をやめ、推奨を先に述べてから相手の意見を尋ねます。提案か誘導かを分けるのは、言い方ではなく**土台に価値観があるかどうか**です。

- **居酒屋のたとえ**：ひどい店の話をした後で「そこに行きたい？」と聞くのは不自然。中立に尋ねると、その選択肢にも検討の価値があるように聞こえる。
- **同じ言葉でも、順番で意味が変わる**：2ndを飛ばして「心肺蘇生はしないほうがよい」と言えば、判断が正しくても誘導になる。「もう苦しみたくない」という価値観を聴いた後なら、同じ言葉が価値観を医療行為に翻訳した提案になる。
- **決断の重さは医療者が引き受ける**：「しない」と決めることは、医療の素人には大きな心理的負担になる。はい／いいえで聞くのは医療者にとっては楽だが、責任を相手に預けている。

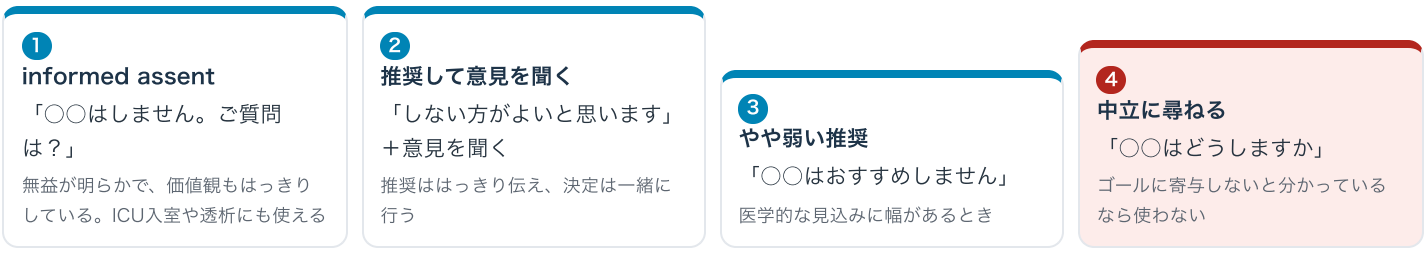


図2. 提案の強さの段階。左ほど強く、右端の中立な問いはゴールに寄与しないと分かっているときには使わない。言い方は要旨。

どの段を選ぶかは§0の3要素で決めます。**医学的な確かさ・価値観の明確さ・委ねたい気持ち**がそろうほど左に寄せ、そろわなければ右に下げます。価値観が聴けていなければ、提案の前に2ndに戻ります。

強い側のもう一つの言い方

informed nondissent は、方針を示したうえで反対なら言ってほしいと伝えて拒否の余地を明示する言い方です [AHA 2025]。informed assent と同じく、決定の重荷を医療者が引き受ける側にあります [Curtis JAMA2020]。

§4 事前指示書の7条件と理想のACP — 書類より価値観の共有

事前指示書が実際の場面で効くには7つの条件がすべて要り、そろう確率は思ったより低くなります。ACPで力を注ぐべきなのは書類ではなく、価値観を家族と共有し続けることです。

事前指示書が効くまでに必要な7条件

表4｜7条件（A〜G）

記号	条件
A	本人が自分の価値観をわかっている
B	代理人を決めている
C	代理人が本人の価値観を知っている
D	書類にしている
E	その場に書類がある
F	代理人がその場にいる
G	医師が適切に話し合いを進める

48%
各条件が90%で満たされても、7つそろう確率（0.9の7乗）

0.8%
各条件が50%なら、7つそろう確率

- **よくある失敗**：Aを経ずにDだけ作る。勧められて書いたが内容を覚えていない。
- **逆効果のことも**：書類を作ったことで「もう話さなくていい」となり、家族が本人の思いを知る機会を失う [Auriemma JAMA Intern Med2022]。
- **AからFまでそろっても、Gで崩れる**：挿管しなければ亡くなると告げられて同意を迫られたとき、書類どおりに答えられる家族は少ない。法的効力があっても、家族が納得しなければ機能しない。

理想のACP

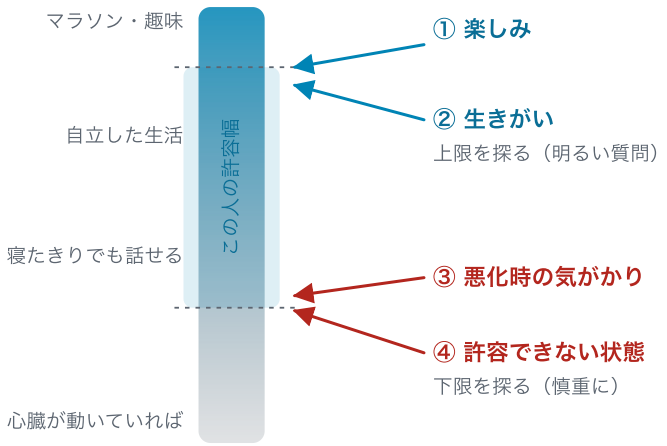
✓ 理想のACPの3点

- **本人が自分の価値観を言えること**が根幹で、ここは譲れない。
- 代理人を1人決めるより、**価値観ができるだけ多くの家族に共有されている**ことのほうが大事。遠くにいた家族ほど「全部やってくれ」と介入してくる（いわゆる Daughter from California）。原因は、その家族が本人の思いを聞いていないこと。
- **事前指示書のことは忘れてよい**。元気なうちに3rdの治療選択まで決めるのはハードルが高すぎる。その時が来たら、積み重ねた会話で共有された価値観をもとに、家族と医療者が話し合って選ぶ。

ACPも Goals of Care の会話も、1回きりのイベントではなく続けるプロセスです。

§5 ACPで尋ねる4つの質問 — 上限と下限を探る

人生の状態は白か黒かではなくグラデーションです。ACPは、その人が上はどこまで望み、下はどこまで許容するかの幅を、明るい質問から順に探る作業です。



模式図。上限・下限の位置は人によって違う。

図3. 4つの質問で、人生の状態のグラデーションに上限と下限を引く。①②は答えやすい明るい質問で上限を、③④は慎重に下限を探る。

> 質問の順番そのものに意味があります。**答えやすい楽しみから入り**、関係ができてから下限の質問に進みます。

表5｜4つの質問と、聞き方のコツ

順	尋ねること（要旨）	狙いとコツ
1 楽しみ	いま楽しみにしていること	上限を探る。答えられない人はまずいない。「価値観は」「大切なことは」は抽象的で答えにくい
2 生きがい	人生を意味あるものにしていること	前向きな面をさらに深く聞く。詰まったら「大切なこと」に言い換える。小児なら将来なりたいもの
3 気がかり	今後状態が悪くなったときに一番気がかりなこと	下限に向かう。「今」ではなく**「悪くなったとき」**という前置きを意識して添える。無造作に聞かない
4 許容できない状態	こうなったら生きていたくない、という状態はあるか	ACPの鍵。伝わらなければ具体例を挙げる（食べることが生きがいなので胃ろうは嫌、意思疎通できないなら嫌、など）

- 「死んだほうがまし」という言い方は強すぎるので、患者に尋ねるときはほとんど使わない。
- **死が迫った状況では4番目は文脈に合わない**。ICUの Goals of Care では使わず、2ndの他の質問で下限を探る。

ICUの2ndステージで使える問いの例（要旨）

- 今の話を聞いて、一番気がかりなことは何か
- ご本人はどんなことを大切にする方か／元気だったころの楽しみは何だったか
- 以前、悪くなったときの話をしたことがあるか
- ご本人がいまの状況を理解したら、何と言うと思うか

§6 予後を伝える ― 「死ぬんですか？」に答える

予後ははぐらかさず、シンプルに答えてから沈黙します。「どれくらい？」には、許可を得てから時間の単位で答えます。

- 2分サマリーの骨格は、手を尽くしても改善の兆しがないこと、続けても助けるのはきわめて難しいこと、の2点。
- 「死ぬんですか？」と聞かれたら、別れの時が近づいていると率直に答え、**その後は沈黙する**。沈黙が気まずくて、要らない情報を話し足すのが典型的な失敗。
- 説明の後に聞かれて「どうしてそう思うのですか」と返し、答えないのはずるい。何の文脈もなく聞かれたときだけ、理由を尋ねて真意を探る。

「どれくらいですか？」に5段階で答える（伊藤・大内『緊急ACP』の型・言い方は要旨）

家族
あとどれくらいなのでしょうか。

医師
1 許可 お伝えしてもよろしいですか。
聞きたくない家族がいれば、面談後に希望する人にだけ伝える。

医師
2 前置き 正確ではないが、目安なら示せると前置きする。

医師
3 単位 数時間〜数日／数日〜数週／数週〜数か月／数か月〜数年、の単位で答えると伝える。

— 沈黙 —

医師
4 答え この方は……数日〜数週と考えます。
ゆっくり話し、前後に沈黙を置く。

— 沈黙 —

医師
5 感情 驚かれましたか。
感情に名前をつける（NURSE の Name）。驚いていれば感情に対応し、「わかっていた」なら2ndステージへ。

「わかりません」で済ませるのは不誠実です。どの時間単位かすら見当がつかないことは、実際にはほとんどありません。特定の数字ではなく、時間の単位で伝えます。

§7 「本人には言わないで」と言われたら

まず家族の心配に対応し、そのうえで、どこまで知りたいかを本人に聞きます。隠すことは本人を守るとは限りません。

1. **家族の心配を聴く**：希望を失う、落ち込む、などの心配を聴き、NURSE で感情に対応する（Name＝心配になりますよね、Respect＝本当に大切に思っておられるのですね、など）。
2. **話さないほうが不安を強める**：何が起きているかわからないことは、悪いことを知っているより辛い [Wright JAMA2008]。本人が知りたがっているときに、それを無視することはできない。
3. **家族と一緒に本人に尋ねる**：「皆さんに伺っているのですが」と一般化（normalize）してから、病状をどこまで知りたいかを聞く。

4. **家族がその質問自体を拒むとき**はケースバイケース。一番の気がかりを中立に聞き、本人が病状を尋ねてきたらもう逃げられない。「特にない」なら、病状は家族と相談して進めてよいか了承を得る。

医療の実践は場所や文化で変わってよい。予後が数日のときは、伝えて得られる利点（人生を締めくくれる）と負担を比べて決めます。

§8 「時間がない」への答え — 2ndを飛ばすと遠回りになる

時間がないときほど、ゴールの段は削れません。2ndは慣れれば2〜3分、5〜10分あれば深く話せます。

COVID-19流行期・ニューヨークのERの実例（90歳、転移性肺がん。言い方は要旨）

それまで

はい／いいえ **レジデントが1時間電話で話しても、息子さんは「全部やってほしい」と言い続けていた。**

医師

1st どうやっても助けられないことを、はっきり伝えた。

医師

2nd 一番の気がかりは何ですか。

息子さん

母は苦しいのですか。

医師

3rd 苦痛をとる薬を使い、機械やチューブにはつながない方針を推奨した。

— 5分で合意 —

- はい／いいえで聞けば、決断が家族の重荷になる。2ndを飛ばして「やらないほうがいい」と言えば誘導になる（北風のアプローチ）。
- 2ndを飛ばすと判断材料が医学情報だけになり、「生きるか死ぬか」の判断になる。その結果、挿管・透析・中心静脈カテーテル・昇圧薬・心肺蘇生まで、本人が望まないかもしれない治療が全部行われる。

§9 反復とスキル — オウム返しをやめ、磨き方を決める

語尾を繰り返すだけの反復は思考停止です。理由を聞いて掘り下げます。コミュニケーションはセンスではなく、手術手技と同じく練習で上達するスキルです。

反復ではなく、理由を聞く

- 「もう良くならない」という言葉を語尾だけ変えて繰り返すと、相手は苛立つ。「どうしてそう思うのですか」と理由を聞けば、症状がとれていないのか、病状を誤解しているのかで打つ手が変わる。
- 掘り下げる質問は **Tell me more／Why?／What else?** の3つ。否定（そんなことないですよ）も励まし（頑張りましょう）も、価値観の押しつけになる。
- 反復が役立つ場面もある：聞き取った内容の確認、ほかの参加者への中継、要約しての確認。

スキルの磨き方

上達の手順

1. 指導医のフレーズを一言一句書き留めて真似る
2. 自分の言葉に直す
3. 意地悪なフィードバックを頼む
4. 面談のたびに学びを1つ書き留める（5分で済む）

「センスで決まる」「教えられない」「経験を積めば自然にうまくなる」はどれも誤り。面談を終わらせられることは、質の保証にはなりません。

§10 ICUでの使いどころ

ICUの家族面談では、2分サマリー、一番の気がかり、ゴールに沿った推奨、の3つを1セットで使います。

ICUでの3つの場面

- **家族面談の型**：2分サマリー → 一番の気がかりを聞く → ゴールに沿った推奨（informed assent を含む）。終末期を定義せずプロセスで決める、という4学会合同ガイドラインの考え方とも合う。
- **DNARの聞き方**：コードステータスを はい／いいえ で聞かない。DNARの対象は心停止時の心肺蘇生だけで、他の治療を控える意味ではない。
- **予後の数字**：特定の数字は使わず、時間の単位で伝える（§6）。

出典と関連資料

- 中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』メジカルビュー社、2024年
- 中川俊一、m3.com 臨床ニュース連載（全10回、2024年12月12日〜2025年2月13日。上記書籍からの転載）
- 本文で触れた文献：Nelson, AJRCCM 2010／Fried, NEJM 2002／Elwyn, BMJ 2010／Curtis, JAMA 2020／Auriemma, JAMA Intern Med 2022／Wright, JAMA 2008／AHA 2025（倫理）／伊藤・大内『緊急ACP』

このページは上記連載・書籍の論点を整理した要約で、原文の転載ではありません。

関連資料：ICUで知っておくべき臨床倫理